서는 스트레스원에 대한 문제 해결적인 적극적 대처가 오히려 정서적 신체적 병리 증상을 더 악화시키는 것으로 보인다.

대부분의 대학생들이 대학수학능력검사 점수에 맞추어 전공지식과 진로에 대한 확신없이 대학에 진학하였다가(이지헌, 이은희, 이득연, 임현선, 최태산, 1998) 대학진학 후에도 자신의 전공과 관련된 일관적이고 장기적인 진로설정을 하지 못하고 주로 4학년 때 구체적인 진로결정을 하다보니(황상민, 이세안, 1996), 3-4학년 때 진로설정 및 취업관련 갈등으로 인하여 심리적 고통을 경험하는 것으로 보인다(이은희, 송진한, 이지헌, 1998). 이러한 진로설정 및 취업관련 갈등은 자존감을 저하시켜서 결국은 우울증을 유발하는 것으로 나타났다(정의석, 노안영, 2001).

IMF를 전후하여 대학생들이 상담실에 찾아와 호소하는 문제가 학업 및 진로, 우울 및 자살문제, 불안 및 강박증상의 호소문제가 증가한 것으로 나타났는데(박현순, 1999), 최근 우리나라는 경기불황으로 인한 취업한파가 지속되면서 구직자 10명중 6명은 취업에 대한 스트레스로 우울증이나 소화불량, 불면증, 두통, 대인기피증 등의 질병에 시달리고 있는 것으로 나타났다(연합뉴스, 2003, 8, 20). 이들의 35.2%는 이러한 취업스트레스에 대해서 주로 별다른 대책없이 지내고 있으며 32.9%는 미취업을 비관해서 자살을 생각해 본 적이 있다고 응답하였다.

대처방식의 효과성은 상황에 대한 통제가능성(Conway & Terry, 1992)에 대한 주관적인 지각(Endler, Speer, Johnson & Flett, 2000)이 중요하다. 그런데 쉽게 해답을 찾을 수 없는 문제를 풀다가 계속적으로 좌절을 경험한 피험자들이 그 후로 쉽게 해결할 수 있는 문제에 대해서도 해결하려는 시도를 하지 않고(Kofta & Sedak, 1989) 무력감에 빠져 우울증을 유발하는 경우처럼(Seligman, 1975; 장형석, 2000에서 재인용), 극심한 취업난으로 대학졸업자의 56%가 취업하지 못하고 있는 현실(동아일보, 2003. 6. 10)에서 대학생들의 적극적 구직노력은 개인이 통제할 수 없는 경제적, 사회적 요인으로 인하여 오히려 지속적인 좌절 경험을 통한 무기력 심리를 유발하여 결국은 우울증상을 심화시키는 것으로 보인다.

따라서 진로설정 및 취업문제로 인한 갈등을 심하게 겪고 있는 대학생들을 대상으로 한 진로 및 취업 상담을 실시할 때에는 구직을 위한 구체적이고 직접적인 노력에 초점을 맞추기 보다는 떨어진 자존감을 향상시키는 상담전략을 통하여 우울과 자살을 예방할 수 있을 것으로 여겨진다. 즉 스트레스에 대한 심리치료적 개입은 일반적으로 예방(스트레스 관리 훈련)과 치료(상담)의 형태를 통하여 이루어지는데(Hardy & Barkham, 1999), 장기적인 진로 및 취업관련 갈등을 겪고 있는 대학생들에게는 상담을 통한 심리치료적 개입이 보다 바람직한 전략임을 시사한다.

결론적으로 본 연구를 통하여 대학생들이 경험하는 우울증상이 심각한 수준이며, 주로 학업문제와 진로문제로 인한 스트레스를 가장 많이 경험하며, 친구와 가치관 문제로 인한 생활스트레스가 정신 병리적 증상과 연관되며, 문제 중심적 대처는 우울증상을 떨어뜨리고 정서 중심적 대처는 우울증상을 증가시키는 것을 확인하였다. 또한 장래문제로 인한 갈등을 심하게 겪고 있는 대학생들의 경우에는 문제 중심적 대처방식의 사용이 오히려 우울증상을 증폭시키는 것을 확인하였다.